

INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

— Variante Profesional —

PACIENTE

Felipe Andrés Rincón Mendoza

DOCUMENTO

CC 80123456

FECHA NACIMIENTO

14/03/1992

EDAD

34 años, 9 meses

SEXO

Masculino

ESCOLARIDAD

Universitaria

LATERALIDAD

Diestro

FECHA DE EVALUACIÓN

10/01/2027

ORDEN N°

—

PROTOCOLO APLICADO

screening_parcial

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre:	Felipe Andrés Rincón Mendoza	Lateralidad:	Diestro
Documento:	CC 80123456	Ocupación:	Ingeniero de software
Fecha de nacimiento:	14/03/1992	Ciudad:	Medellín
Edad:	34 años, 9 meses	Acompañante:	No acude con acompañante
Sexo:	Masculino	Remite:	Consulta particular
Escolaridad:	Universitaria	EPS / Asegurador:	Sura EPS

MOTIVO DE CONSULTA

Dificultades atencionales reportadas por su empleador. Desea evaluación neuropsicológica para descartar TDAH adulto.

ANTECEDENTES

Patológicos / Médicos

Sin antecedentes médicos de relevancia.

Farmacológicos

Sin medicación actual.

Familiares

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

Psiquiátricos

Sin antecedentes psiquiátricos previos.

Traumáticos

Niega TEC previo.

RESUMEN EJECUTIVO

Pirámide invertida: conclusión, hallazgos, implicación

Conclusión

Perfil neuropsicológico sin datos suficientes para un resumen global.

Implicación

El perfil es consistente con funcionalidad preservada; se recomienda seguimiento de rutina.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Hallazgos cualitativos durante la administración

Apariencia y conducta

Evaluación neuropsicológica. Paciente colaborador.

Atención y concentración

Paciente acude solo, en horario laboral, manifiesta presión por entrega de resultados rápidos. Conectado pero ansioso durante la entrevista inicial.

Memoria

No fue posible evaluar — paciente deserta antes de la segunda sesión.

Praxias y gnosias

Sin alteraciones significativas en praxias ni gnosias.

Lenguaje

Lenguaje fluido y coherente durante la entrevista inicial. Vocabulario técnico profesional.

Funciones ejecutivas

Autoreporta olvidos frecuentes en el trabajo y dificultad para sostener atención en reuniones largas (>30 min).

Emociones y comportamiento

Ánimo eutímico. Niega ideación suicida. Refiere estrés laboral moderado.

Cociente intelectual (observación)

Perfil cognitivo: INCONCLUSO - Deserción prematura

RESULTADOS CUANTITATIVOS

Puntajes por prueba y perfil cognitivo del paciente



Tabla detallada de puntajes

Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
Inventario de Beck BDI-II	8	8	-6.13	Mínima

RESUMEN PARA LA FAMILIA

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó Felipe. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

¿Qué encontramos?

Aún no tenemos suficientes resultados para darte un resumen detallado. Conversa con tu psicólogo/a al respecto.

Áreas para apoyar (en qué trabajar)

¿Qué recomendamos?

Recomendación: Se sugiere psicoeducación sobre el proceso de evaluación neuropsicológica completa (3-4 sesiones adicionales). (consulta con tu psicólogo/a para detalles específicos). Recomendación: Reagendar dentro de los próximos 30 días. Si decide no continuar, documentar decisión informada. (consulta con tu psicólogo/a para detalles específicos). Recomendación: Considerar intervención breve en técnicas de manejo del tiempo y atención antes de la evaluación completa. (consulta con tu psicólogo/a para detalles específicos).

Preguntas frecuentes

¿Mis resultados son permanentes?

No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica, con los apoyos adecuados y con un buen ambiente. Estos resultados son una foto del momento actual: tu psicólogo/a te ayudará a entender qué puede cambiar y qué se mantiene más estable.

¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?

Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto NO significa que haya algo mal: el cerebro humano es diverso y cada uno tiene su propio perfil.

¿Qué es el 'cociente intelectual' (CI)?

El CI es un número que resume el rendimiento global en diversas pruebas. NO define tu inteligencia total ni tu valor como persona: es solo una medida parcial de ciertas habilidades de razonamiento, memoria y atención. Varía según el contexto, la fatiga, el ánimo del día y muchos otros factores.

¿Necesito otro tipo de evaluaciones?

Tu psicólogo/a te dirá si se necesitan otros estudios (por ejemplo, evaluación pedagógica, médica, o del lenguaje). No te preocupes si no entiendes algún término: puedes preguntar siempre.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

DSM-5 / CIE-10

Diagnóstico codificado

Código CIE-10: Z00

Impresión diagnóstica: INCONCLUSO - Deserción prematura

RECOMENDACIONES

Plan de manejo agrupado por área y prioridad

Familiar

- Reagendar dentro de los próximos 30 días. Si decide no continuar, documentar decisión informada.
- Se sugiere psicoeducación sobre el proceso de evaluación neuropsicológica completa (3-4 sesiones adicionales).

Terapéutica

- Considerar intervención breve en técnicas de manejo del tiempo y atención antes de la evaluación completa.

Recomendaciones del cuadro clínico

Banco de recomendaciones clínicas sugeridas para el cuadro identificado. El clínico debe seleccionar las aplicables antes de emitir el informe definitivo.

Discapacidad intelectual adulto (F70–F79) · Adulto (18–49 años)

- Valoración para proceso de interdicción / apoyos legales según Ley 1996 de 2019.
- Programa de inclusión laboral / ocupacional adaptado a su nivel.
- Entrenamiento en AVD y autonomía: transporte, manejo de dinero, autocuidado.
- Acompañamiento psicosocial para red de apoyo familiar.
- Manejo de comorbilidades psiquiátricas (ansiedad, depresión) — frecuentes.
- Control médico integral — mayor riesgo de enfermedades no detectadas por dificultad para comunicar síntomas.
- Actividades de estimulación cognitiva adaptadas al nivel funcional.
- Psicoeducación sexual y prevención de abuso.